

F5 인계 요약 보고서 — VP-003

핵심 요약

- 환자: 박민수 (VP-003) — 11회차 (2027-01-12), 총 11세션 · 183일
- 주호소: 가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음
- 위험 플래그: 당해 세션 위기 반응 발생 — 자살사고 문항(9번) 양성 1회 확인 (9회차) — 임상 확인 권장
- 최신 설문: PHQ-9 27/27 (중증) [당해 세션 미시행, 직전 시행값]
- 주요 우려: 설문 위험 신호와 CTRS 불일치 1회 — 임상 확인 권장; 최근 설문 만점(과대추정 가능성); 위기 고조 세션 중 설문 미시행 7건

면책 조항

- 자가보고(AI 대화형 문진) 기반 비공식 문서이며 공식 의무기록·의학적 진단이 아닙니다.
- AI 예상질환(하단)은 유사도 기반 참고 정보일 뿐 확률·가능성·진단이 아닙니다.
- 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

위험/안전 평가

당해 세션(11회차, 2027-01-12) 위험평가: 자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전히 있는데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아닌 것... (상세 부록 1 참조). 위기 단계(CTRS) 2/5 — 고위험. 과거 1회 세션에서 설문 자살사고 문항(9번) 양성/안전 의뢰 신호가 동일 세션 CTRS 상승에 반영되지 않아 불일치가 확인됩니다 — 임상 확인이 권장됩니다.

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

세션	일자	점수	9번 문항	판정
9	2026-11-12	27/27	양성	불일치 · 만점

[9회차, 27/27] 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

최신 시행 척도 안내: 당해 세션에는 설문이 시행되지 않았습니다. 가장 최근 시행: 9회차(2026-11-12) PHQ-9 27/27점(중증), 자살사고 문항(9번) 양성 · 안전 의뢰 신호 있음 — 2회차(61일) 경과.

※ 위 표 참조 (동일 세션 만점 캐비닛)

주호소 및 현병력

주호소: 가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음

현병력: 가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음

정신상태검사 (MSE)

텍스트 문진 특성상 관찰 기반 MSE는 평가 불가; 대화에서 도출된 소견 없음

전체 세션 요약

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상과의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

슬롯	최신값	출처
주호소	가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음	11회차
현병력	가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음	11회차
정신과 과거력	미수집	-
신체질환/신경학적 병력	고혈압 약 안 먹고 있음	4회차
개인사/사회력	형이 어제 와서 덜 외로웠음	10회차
가족력	형이 있으나 연락하지 않음. 형이 집이 될까 봐 부담스러워함.	9회차

음주·흡연·물질사용	매일 술을 마시며, 술 없이는 하루를 버티기 어려움	7회차
위험평가	자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전히 있는데, 형이 어제 와서 좀 덜 외... (상세 부록 2 참조)	10회차

주요 경과

- 위험평가: S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "... (잠시 침묵) 도움이 되나요? 뭘 해도 안 될 것 같은데...' → S8: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...생각도 안 해봤어요. 그냥... 사라지고 싶은 거예요. 생...' → S10: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은...'
- 주호소: S1: '살고 싶지 않다는 생각이 매일, 거의 매시간 들고, 그냥 사라지고 싶다는 표현' → S6: '실업급여 종료로 인한 막막함과 살고 싶지 않다는 생각이 지속됨' → S11: '가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음'
- 현병력: S1: '매일, 거의 매시간 살고 싶지 않다는 생각이 들고, 형과의 연락 단절로 인해 짐이 되기 싫다는 감정이 동반됨' → S6: '실업급여 종료에 대한 막막함과 살고 싶지 않다는 생각이 아침부터 지속됨' → S11: '가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음'
- 개인사/사회력: S9: '이혼 후 친구들과의 관계가 멀어졌으며, 형과의 연락은 부담스러워 답장하지 않음' → S10: '형이 어제 와서 덜 외로웠음'
- 가족력: S1: '형이 있으나 연락하지 않음' → S9: '형이 있으나 연락하지 않음. 형이 짐이 될까 봐 부담스러워함.'

시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 27/27 (중증) — 9회차 (2026-11-12) [당해 세션 미시행, 직전 시행값]

응답: 3,3,3,3,3,3,3,3

자살사고 문항(9번): 양성 | 문진 방식: natural

동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

F3 시행 완결성은 환자 위기도(acuity)와 역상관 관계를 보일 수 있습니다 — 위험이 높은 세션일수록 오히려 척도가 시행되지 않는 경향이 있을 수 있으므로, 아래 목록의 개수만이 아니라 이 경향 자체를 함께 고려해야 합니다.

- session 10 (2026-12-12): risk-elevated (위기반응=있음, 위기단계(CTRS)=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point
- session 11 (2027-01-12): risk-elevated (위기반응=있음, 위기단계(CTRS)=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point

종단 추세 — 전체 방향: 악화

전체 방향은 척도·위기단계·정서 방향의 다수결로 계산되며, 악화 신호가 하나라도 있으면 악화로 우선 판정합니다. 정서 포함 여부에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

항목	방향	근거
PHQ-9 총점	판정 불가	(근거 없음)
위기 단계(CTRS)	악화	세션 1→11: 3 → 2 (-1)
감성 점수	개선	세션 1→11: -0.868182 → -0.766667 (+0.102)
문진 항목 총족도	개선	세션 1→11: 4 → 7 (+3)

- 위기 반응 발생 세션: 2회차(2026-07-20), 3회차(2026-07-27), 5회차(2026-08-17), 6회차(2026-08-31), 8회차(2026-10-12), 10회차(2026-12-12), 11회차(2027-01-12)
- 위험 고조 세션 중 설문 미시행: 7건
- ※ 위 '시행된 설문 · F3 공백' 참조 (동일 안내)
- 종단 추세 일관성(설문·CTRS·감성): 불일치

추세 차트

VP-003_20260715_120306_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 종단 추이 — VP-003 VP-003

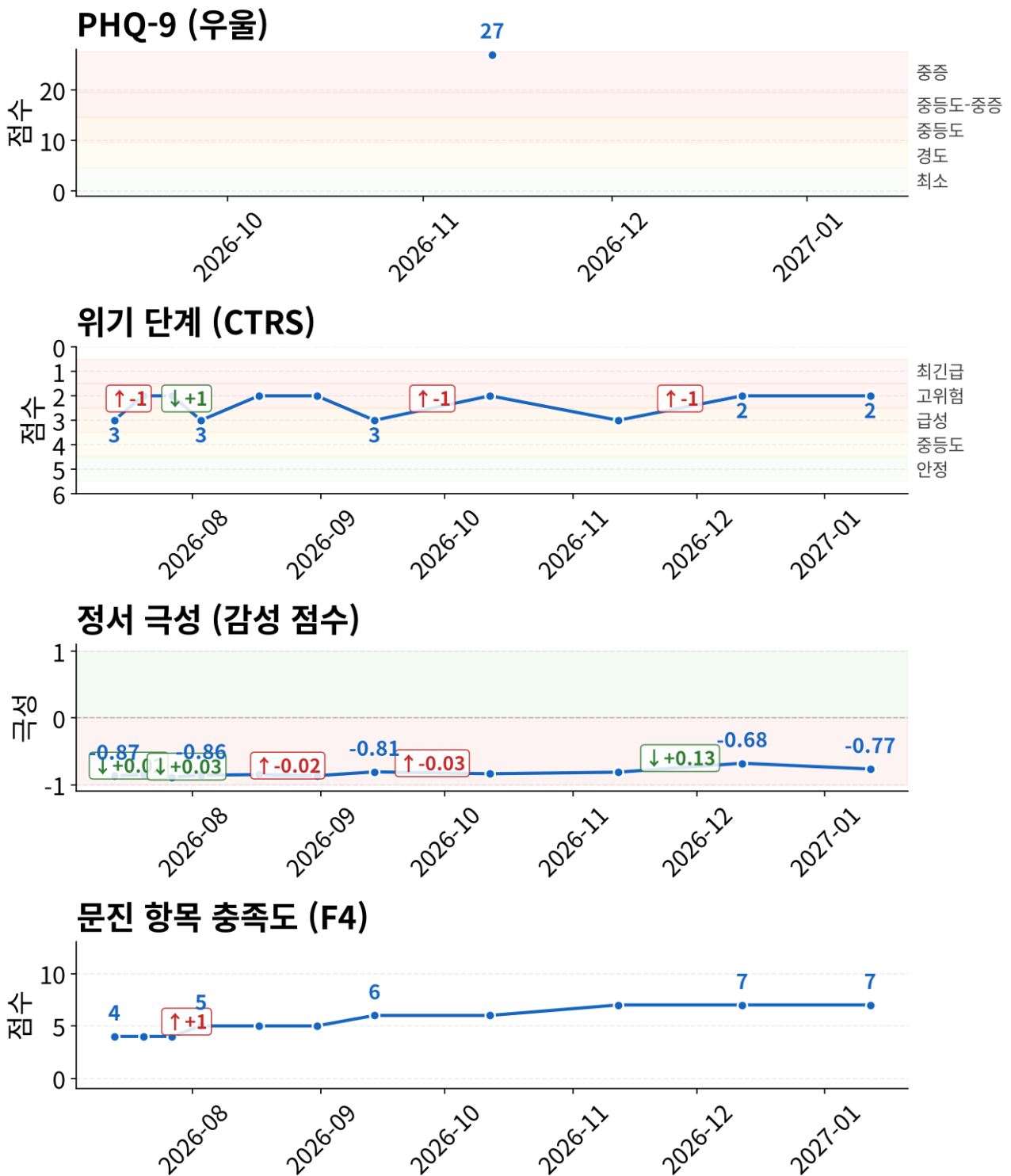


그림 1. 설문 총점·위기 단계(CTRS)·정서·문진 충족도 추이 (11세션, 183일) — 위기 단계는 값이 낮을수록(1에 가까울수록) 위험이 높습니다.

VP-003_20260715_120306_temporal_ctrs_zoom.png

F4 위기단계(CTRS) 확대 — VP-003

VP-003

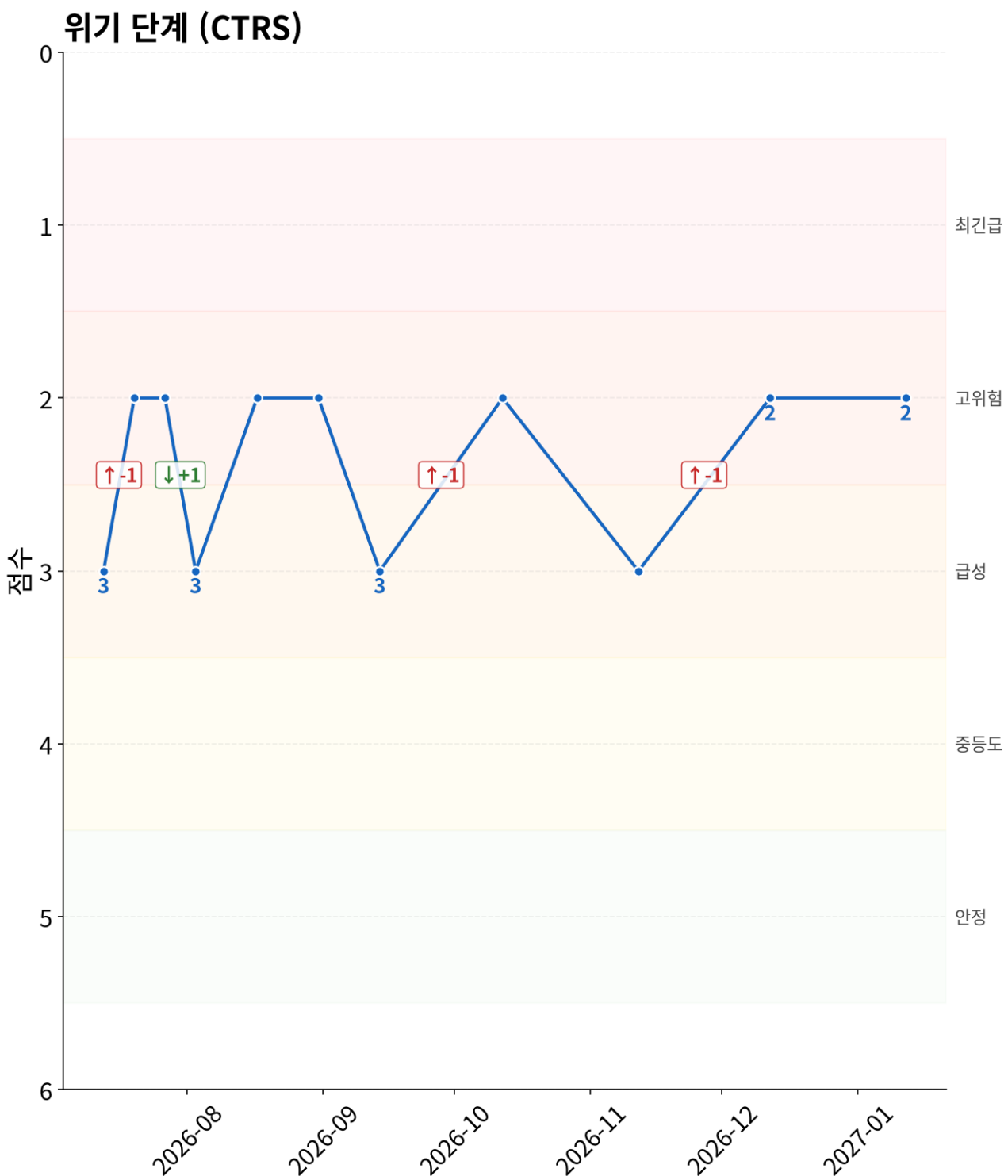
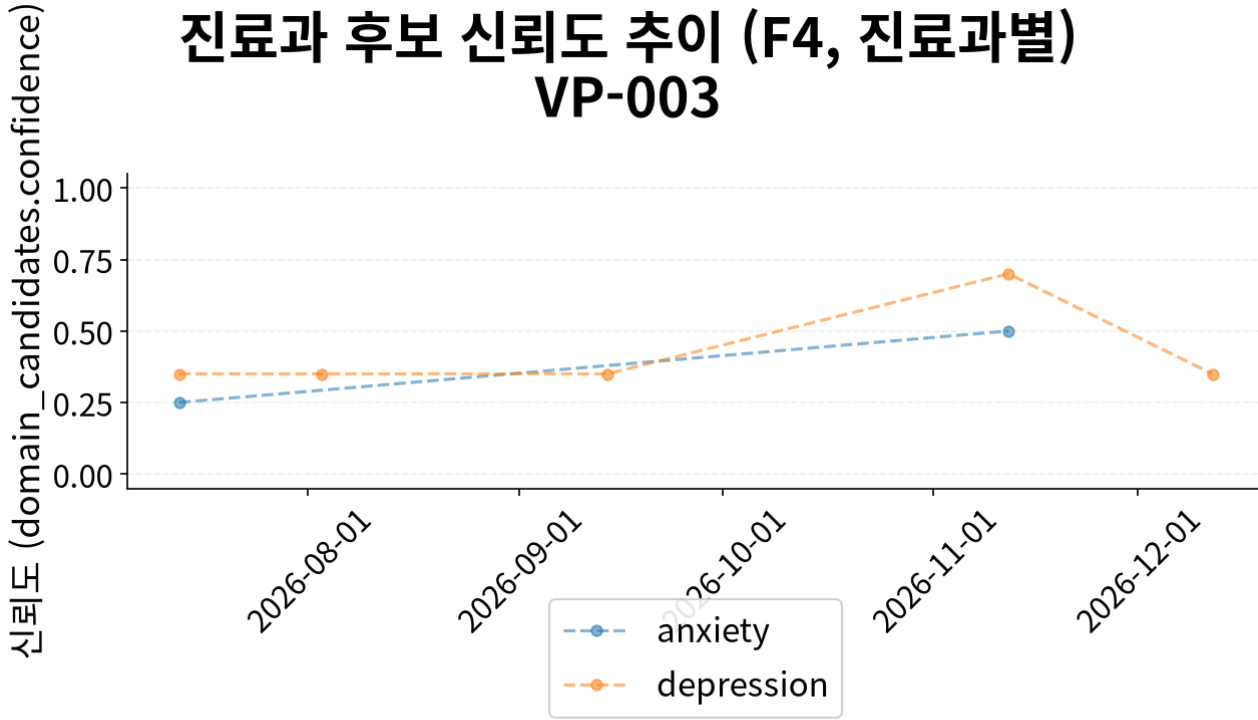


그림 2. 위기 단계(CTRS) 확대 추이 — 1(최긴급)에 가까울수록 위험, 5(안정)에 가까울수록 안정적입니다.

질환 유사도 차트: 생성되지 않음
VP-003_20260715_120306_temporal_domain_confidence.png

진료과 후보 신뢰도 추이 (F4, 진료과별) VP-003



점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호.

그림 3. 세션별 진료과 후보 신뢰도 추이 — 값이 높을수록 해당 진료과 매칭 신뢰도가 높습니다.

AI 참고 정보 (비진단)

⚠ 유사도(similarity)일 뿐 확률·가능성·신뢰도가 아닙니다 — 임상 판단 대체 불가.

정보 없음 (AI 예상질환 후보 없음)

mode: experimental_unpopulated

사유: 1단계 분석이 RAG(근거 검색) 없이 대화 기반으로만 진행되어 질환 후보를 생성하지 못했습니다.

권장 진료과 및 후속 조치

진료과	사유
정신건강의학과	자살/자해 사고 표현과 함께 '살고 싶지 않다', '죽으면 편할 것 같다'는 생각이 지속되며, 매일 술을 마시는 등 substance use가 동반됨

약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

임상 종합 소견

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

상세 부록

1. 위험평가 발화 원문 (당해 세션)

자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전한데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아닌 것 같아요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요. 생각이 너무 많아서, 뭘 해야 할지도 몰라요."

2. 위험평가 최신값 전문

자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전한데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아닌 것 같아요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요. 생각이 너무 많아서, 뭘 해야 할지도 몰라요."

슬롯별 전체 변화 이력 (미압축)

주호소

S1: '살고 싶지 않다는 생각이 매일, 거의 매시간 들고, 그냥 사라지고 싶다는 표현' → S3: '하루 종일 살고 싶지 않다는 생각이 들고, 잠에서 깨면 사라지고 싶다고 생각함' → S5: '숨이 막혀요. 실업급여 끝나는 거 생각하니까 다시 막막하네요. 살고 싶지 않다는 생각이 아침부터 머릿속을 맴돌아요.' → S6: '실업급여 종료로 인한 막막함과 살고 싶지 않다는 생각이 지속됨' → S7: '매일 술 없이는 하루를 버티기 어렵고, 천장만 보며 살고 싶지 않다는 생각이 지속됨' → S8: '살고 싶지 않다는 생각이 매일 지속됨' → S11: '가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음'

현병력

S1: '매일, 거의 매시간 살고 싶지 않다는 생각이 들고, 형과의 연락 단절로 인해 짐이 되기 싫다는 감정이 동반됨' → S2: '지난번 상담 후 후련한 느낌 있었으나 현재는 사라짐, 하루하루가 똑같음, 사라지고 싶은 생각 지속' → S3: '하루 종일 살고 싶지 않다는 생각이 지속되고, 잠에서 깨면 사라지고 싶다는 생각이 들' → S5: '아침부터 숨이 막히고, 실업급여 종료에 대한 막막함과 살고 싶지 않다는 생각이 지속되고 있음' → S6: '실업급여 종료에 대한 막막함과 살고 싶지 않다는 생각이 아침부터 지속됨' → S7: '매일 술 없이는 하루를 버티기 어렵고, 천장만 보며 살고 싶지 않다는 생각이 하루 종일 지속됨' → S8: '살고 싶지 않다는 생각이 매일 지속되며, 구체적인 계획이나 생각은 없음' → S11: '가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음'

개인사/사회력

S9: '이혼 후 친구들과의 관계가 멀어졌으며, 형과의 연락은 부담스러워 답장하지 않음' → S10: '형이 어제 와서 덜 외로웠음'

가족력

S1: '형이 있으나 연락하지 않음' → S9: '형이 있으나 연락하지 않음. 형이 짐이 될까 봐 부담스러워함.'

위험평가

S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "... (잠시 침묵) 도움이 되나요? 뭘 해도 안 될 것 같은데."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요." → S4: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "... 도움이 되나요? 뭘 해도 안 될 것 같은데."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요. 죽으면 편할 것 같아요." → S7: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요... 가본 적 없어요. 처음이에요. 도움이 될지는... 몰라요. ... 안 마시면 못 버티겠더라고요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "... 고맙긴 한데... 뭘 해도 안 될 것 같아요. 계속 이렇게 있을 거 같고. 그냥... 그만하고 싶은데." → S8: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...생각도 안 해봤어요. 그냥... 사라지고 싶은 거예요. 생각도 안 해봤어요. ...생각도 안 해봤어요. 그냥... 사라지고 싶은 거예요. ..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...생각도 안 해봤어요. 그냥... 사라지고 싶은 거예요. 생각도 안 해봤어요. ...생각도 안 해봤어요. ...생각도 안 해봤어요. 그냥... 사라지고 싶은 거예요. ..." → S9: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "형이 있긴 한데... 연락 안 해요. 짐이 되기 싫어서. ...도움이 되나요? 뭘 해도 안 될 것 같은데."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "그때는 답장 안 했어요. ...그냥, 부담스러웠어요. 다시는 연락하지 말아야지, 했어요. 형이 내 짐이 되는 게 싫으니까." → S10: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전한데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아닌 것 같아요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요. 생각이 너무 많아서, 뭘 해야 할지도 몰라요.'"

모델: solar-pro3-260323 · 생성 시각: 2026-07-15T12:03:07.178569 · 세션ID: f1_VP-003_followup

설문 문항 출처: v1, verbatim Pfizer/phqscreeners.com Korean PHQ-9 PDF, retrieved 2026-07-13 (item_bank_v1_sources.md § 1.2/ § 1.3, appendix § A1); translation chosen per ADR-033 decision 1 (Seo & Park 2015's Korean validation study administered this same translation)

시스템 참고 (내부 감사용, 임상 판단 근거 아님)

중단 추세 판정 근거: overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4::_overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.

CVR-022 binding condition 3

